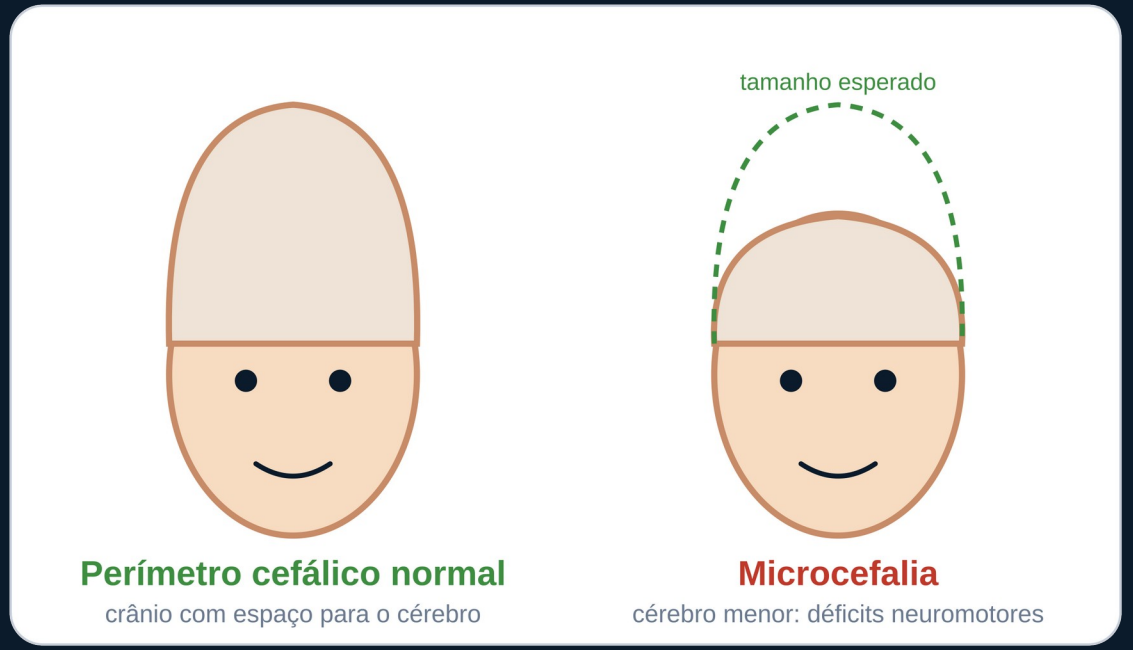
Infecções congênitas e IST

Aula 5 · Unidade IV

Quando o agente atravessa da mãe para o bebê: Zika, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola e sífilis.

2 horas



Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa
Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

ROTEIRO DE HOJE

Ao final da aula você vai saber

1. **Classificar**
   as principais infecções por agente e relacioná-las à transmissão vertical

2. **Descrever**
   o que elas causam no sistema nervoso e no musculoesquelético

3. **Discutir**
   o papel do fisioterapeuta na reabilitação de crianças afetadas

PANORAMA

IST e infecções congênitas

Bactérias

sífilis, gonorreia, clamídia

Vírus

HIV, HPV, herpes, hepatite B, Zika, CMV, rubéola

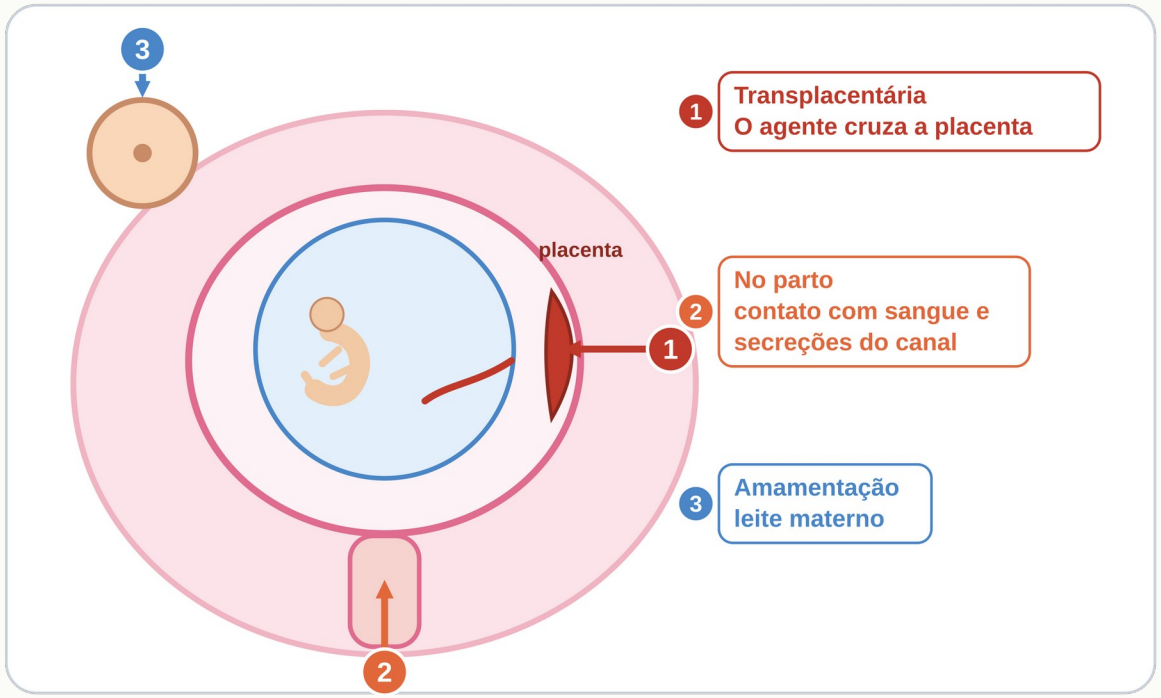
Protozoários

tricomoníase; toxoplasmose (parasita)

Transmissão vertical = de mãe para filho. Nem toda infecção congênita é uma IST.

TRANSMISSÃO VERTICAL

Três caminhos da mãe para o bebê



1 Transplacentária
o agente atravessa a placenta (barreira parcial)

2 Durante o parto
contato com sangue e secreções do canal

3 Amamentação
agente presente no leite materno

Exemplos e prevenção por via

Via	Exemplos	Prevenção
Transplacentária	sífilis, Zika, toxoplasmose, CMV, rubéola	pré-natal: triagem e tratamento; vacinação; controle do vetor
Parto	HIV, hepatite B, herpes genital	profilaxia e escolha da via de parto pela equipe médica
Amamentação	HIV; CMV pode passar pelo leite	orientação individualizada sobre o aleitamento

A prevenção muda conforme a via.

Cinco infecções, cinco marcas registradas

Infecção	Agente	Marca registrada
Zika	vírus (Aedes aegypti)	microcefalia, espasticidade, artrogripose
Toxoplasmose	parasita	coriorretinite, hidrocefalia, calcificações
Citomegalovírus	vírus	surdez neurossensorial progressiva
Rubéola	vírus	catarata, surdez, cardiopatia
Sífilis	bactéria	alterações ósseas e neurológicas, tríade de Hutchinson

TORCH: toxoplasmose, outros (sífilis, Zika…), rubéola, citomegalovírus, herpes.

Zika: da epidemia à fisioterapia

Transmissão

picada do Aedes aegypti; pode passar da mãe para o bebê na gestação

Epidemia 2015–2016

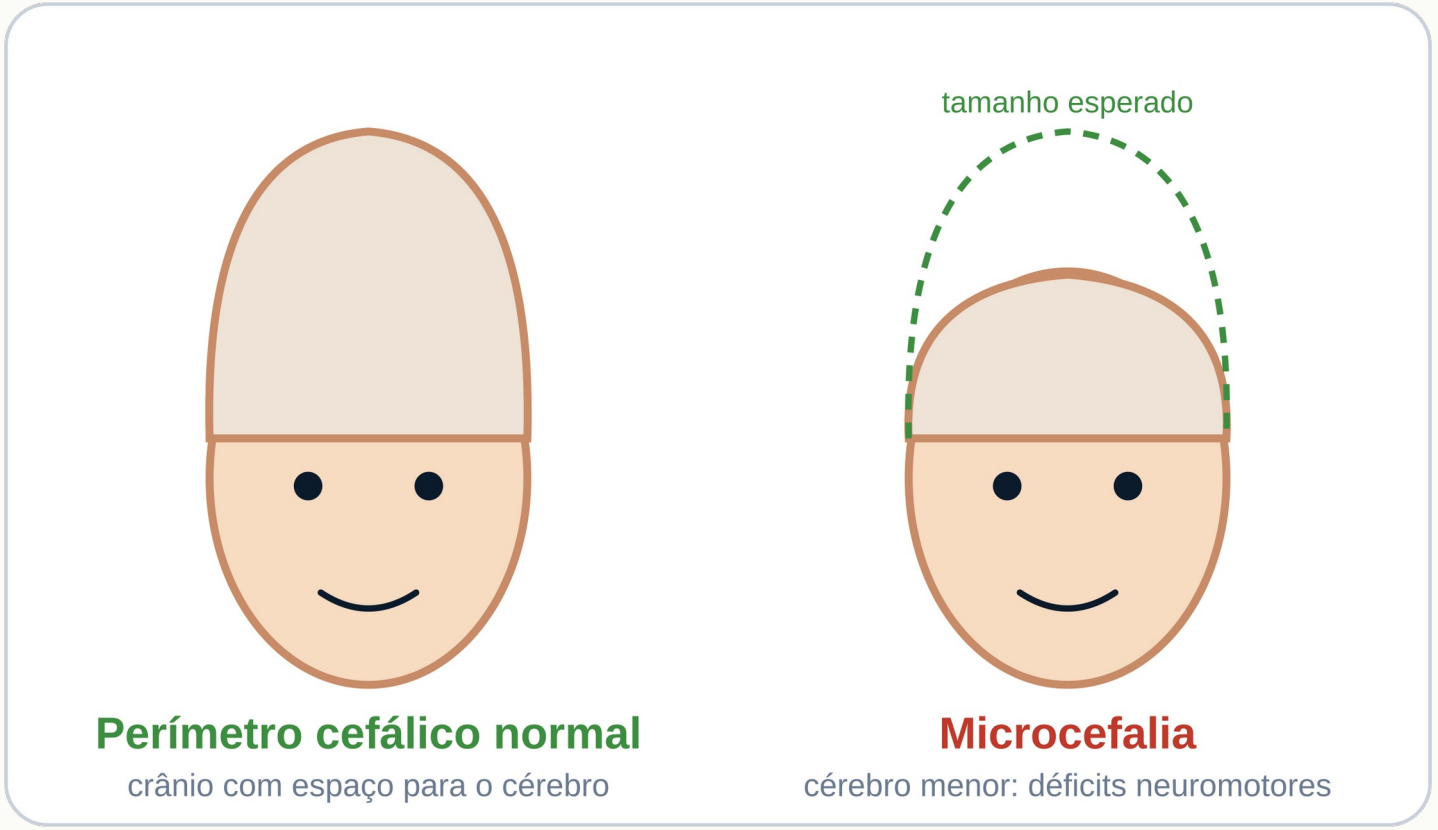
muitos bebês com microcefalia no Brasil

Demanda

uma das maiores da fisioterapia neurofuncional pediátrica

O vírus afeta o cérebro em formação: o dano é do sistema nervoso, não só do tamanho da cabeça.

Microcefalia: o cérebro não cresceu o suficiente



Rosto de tamanho normal, crânio pequeno: desproporção craniofacial. A microcefalia é um sinal do comprometimento do SNC.

Síndrome congênita do Zika

Microcefalia

crânio pequeno por menor crescimento cerebral

Desproporção craniofacial

face normal, crânio pequeno

Espasticidade

tônus aumentado que limita o movimento

Artrogripose secundária

rigidez articular por falta de movimento, causada pelo SNC

Disfagia

dificuldade de deglutir

Epilepsia

crises convulsivas

Começar cedo, com a família junto

Estimulação precoce

aproveita a plasticidade neural dos primeiros meses

Tônus e posicionamento

manejo da espasticidade e posturas adequadas

Prevenção de contraturas

órteses quando necessário

Deglutição

trabalho em equipe com a fonoaudiologia

Família

treinar o manuseio e a estimulação em casa

Equipe

neuropediatria, fono, TO, ortopedia

A tríade: coriorretinite, hidrocefalia, calcificações

Como a mãe se infecta

carne crua ou mal passada, verduras mal lavadas, fezes de gato

Coriorretinite

inflamação da retina e da coroide

Hidrocefalia

excesso de líquor nas cavidades cerebrais

Calcificações intracranianas

depósitos de cálcio no cérebro

CITOMEGALOVÍRUS

A infecção congênita mais comum do mundo

Frequente

a mais prevalente mundialmente

Silenciosa

muitas vezes assintomática ao nascimento

Surdez progressiva

perda neurossensorial que aparece com o tempo

Casos graves

microcefalia e déficits motores

Atraso de desenvolvimento com perda auditiva sem explicação: lembrar do CMV.

RUBÉOLA CONGÊNITA

Catarata, surdez e cardiopatia

Catarata

opacidade do cristalino

Surdez

perda auditiva

Cardiopatia

malformação cardíaca

Prevenção: vacina tríplice viral ANTES da gestação (vírus vivo não se aplica na gestante).

SÍFILIS CONGÊNITA

Alterações ósseas e neurológicas

Agente

Treponema pallidum, que atravessa a placenta; tratável com penicilina

Tíbia em sabre

curvatura anterior da tíbia (forma tardia)

Articulações de Clutton

derrame articular, sobretudo nos joelhos

Tríade de Hutchinson

alterações nos dentes, na córnea e surdez

Forma tardia: após os 2 anos de vida. Teste no pré-natal e tratamento evitam a doença.

QUADRO-RESUMO

Achados e implicações para a fisioterapia

Infecção	Achados	Atenção do fisioterapeuta
Zika	microcefalia, espasticidade, artrogripose, disfagia, epilepsia	estimulação precoce, tônus, órteses
Toxoplasmose	coriorretinite, hidrocefalia, calcificações	estimulação visual e motora
CMV	surdez progressiva; às vezes microcefalia	desenvolvimento, linguagem, equilíbrio
Rubéola	catarata, surdez, cardiopatia	cuidado cardiovascular nos esforços
Sífilis tardia	tíbia em sabre, Clutton, Hutchinson	dor e função de membros inferiores

ATIVIDADE · 5 MINUTOS

Quem sou eu?

Qual infecção congênita é cada pista?

1. Sou transmitido pelo Aedes e causo microcefalia com espasticidade.
2. Causo coriorretinite, hidrocefalia e calcificações.
3. Sou a infecção congênita mais comum e causo surdez progressiva.
4. Dou catarata, surdez e cardiopatia, e há vacina.
5. Dou tíbia em sabre e articulações de Clutton.

PREVENÇÃO

Prevenir: trabalho de toda a equipe

Pré-natal

triagem e tratamento (sífilis, toxoplasmose, HIV)

Vacinação

rubéola e outras, antes da gestação

Controle do vetor

combate ao Aedes e uso de repelente

Preservativo

previne IST

O fisioterapeuta orienta em grupos de gestantes e na atenção primária.

FISIOTERAPIA

O fisioterapeuta acompanha por anos

Avaliar

desenvolvimento neuropsicomotor

Estimular

estimulação precoce (0–2 anos)

Prevenir

deformidades secundárias

Adaptar

órteses

Orientar

a família

Acompanhar

ao longo do crescimento

SEMINÁRIO EM GRUPOS · 30 MINUTOS

Uma infecção por grupo

Preparem 15 minutos. Apresentem 3 minutos cada: Zika, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola ou sífilis.

1. Mecanismo de transmissão vertical
2. Quadro clínico neuromotor esperado
3. Esboço de plano de fisioterapia para 0 a 2 anos

QUIZ RELÂMPAGO

Três perguntas. Levante a mão.

1. A síndrome congênita do Zika está associada a:

A) Focomelia

B) Microcefalia com espasticidade e artrogripose

C) Catarata isolada

D) Escoliose idiopática

2. A tríade clássica da toxoplasmose congênita:

A) Surdez, catarata, cardiopatia

B) Coriorretinite, hidrocefalia, calcificações

C) Focomelia, microcefalia, fenda palatina

D) Icterícia, anemia, hepatomegalia

3. Infecção congênita mais comum do mundo:

A) Rubéola

B) Citomegalovírus

C) Sífilis

D) Zika vírus

RESPOSTAS

Gabarito

Questão 1: B

Zika: microcefalia, espasticidade e artrogripose secundária.

Questão 2: B

Tríade da toxoplasmose: coriorretinite, hidrocefalia, calcificações.

Questão 3: B

O citomegalovírus é o mais prevalente.

Para estudar em casa (discursivas)

Por que crianças com Zika precisam de fisioterapia desde os primeiros meses?

Cite duas alterações musculoesqueléticas da sífilis congênita tardia: tíbia em sabre e articulações de Clutton.

PARA LEVAR

Cinco ideias para guardar

1. **Transmissão vertical**
   transplacentária, no parto e pela amamentação

2. **Zika**
   microcefalia, espasticidade, artrogripose secundária

3. **Toxoplasmose**
   coriorretinite, hidrocefalia e calcificações

4. **CMV**
   a mais comum; surdez progressiva

5. **Fisioterapia**
   acompanha por anos: estimulação precoce e orientação da família

Para estudar mais

- Apostila de Embriologia 2026, Curso de Fisioterapia. Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa.
- MAIA, G. D. Embriologia humana: texto básico para os cursos de ciências da saúde. São Paulo: Atheneu, 2005.
- MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- COCHARD, L. R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre: Artmed, 2003.